



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
KOMITE MUTU
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PERSETUJUAN

Program Kerja Komite Mutu
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2025

Program kerja Komite Mutu ini dibuat sebagai rencana kerja komite mutu selama tahun 2025. peningkatan mutu adalah program yang disusun secara objektif dan sistematis untuk membantu menilai mutu serta kepatuhan kinerja staff dalam memberikan asuhan pada pasien di setiap unit kerjanya.

Disusun oleh:

Komite Mutu RS. Prima Husada

Malang, 16 November 2024

Disetujui oleh:

Direktur Utama PT. Disa Prima Medika

(Endang Susilowati)

LEMBAR PENGESAHAN

Program Kerja Komite Mutu
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2025

Disusun oleh:

Komite Mutu Rumah Sakit Prima Husada



(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP.)

Ditetapkan oleh:

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Program Kerja Komite Mutu Rumah Sakit dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Program Kerja Komite Mutu Rumah Sakit disusun sebagai upaya untuk terselenggaranya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara menyeluruh yang sepenuhnya berorientasi pada standar mutu dan keselamatan pasien serta standar akreditasi.

Program ini akan dievaluasi kembali dan akan dilakukan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi Rumah Sakit. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan segala upaya telah berhasil menyusun program ini yang merupakan kerjasama dengan berbagai pihak.

Pasuruan, 16 November 2024

Penyusun

Komite Mutu Rumah Sakit

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2	2
1.3	2
1.3.1 Maksud	2
1.3.2 Tujuan	2
BAB II	3
GAMBARAN UMUM	3
2.1.	3
2.2.	3
2.3.	3
2.4.	3
2.5.	4
BAB III	4
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	4
.....	4
3.1.	4
3.2.	10
3.3.	25
3.4.	40
3.5.	48
BAB IV	50
MONITORING DAN EVALUASI	50
BAB V	51
PENCATATAN DAN PELAPORAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah berupaya melaksanakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai standar yang ditetapkan. Seiring dengan semakin meningkatnya pendidikan dan latar belakang sosial ekonomi masyarakat, maka sistem nilai dan orientasi dalam masyarakat pun mulai berubah. Masyarakat mulai cenderung menuntut pelayanan umum yang lebih baik, lebih cepat, ramah dan lebih bermutu termasuk pelayanan kesehatan.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan Rumah Sakit tersebut maka fungsi pelayanan di Prima Husada Sukorejo secara bertahap akan terus ditingkatkan supaya menjadi lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kepuasan pasien, keluarga maupun masyarakat, yang dilakukan melalui pembangunan sarana, prasarana, pengadaan peralatan dan ketenagaan serta perangkat lunak lainnya sejajar dengan program pembangunan rumah sakit pada umumnya.

Akreditasi rumah sakit merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan dengan membangun budaya sistem dan mutu. Melalui akreditasi juga diharapkan rumah sakit ada perbaikan sistem yang meliputi *input, process dan product output* (meliputi *output* dan *outcome*)

Namun demikian masih terdapat banyak kendala yang dihadapi yaitu masih belum adanya kesamaan pengertian dasar tentang mutu, konsep dan prinsip demikian pula cara-cara penerapannya. Berdasarkan kedua hal tersebut, agar upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit dapat berjalan seperti yang diharapkan maka perlu disusun buku program kerja tim PMKP sebagai tindak lanjut dari buku pedoman upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dimana buku pedoman tersebut merupakan konsep dan prinsip serta gambaran umum mengenai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo ini, selain itu diharapkan juga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pengelola rumah sakit dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Manajemen mutu rumah sakit merupakan salah satu metode / tuntutan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kesehatan, sehingga rumah sakit mengambil langkah dengan membentuk komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang mengurus tentang manajemen mutu sesuai standart akreditasi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan dan WHO, yang akan berdampak pada bagaimana rumah sakit membuat perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi sampai pada tindak lanjut dari manajemen mutu, dengan hasil akhir diharapkan pasien, keluarga dan staf, pimpinan serta pemilik rumah sakit akan merasa puas, aman dan nyaman dalam menggunakan jasa rumah sakit atau dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dalam organisasi ini. Dengan manajemen mutu yang baik akan tercapai peningkatan mutu secara keseluruhan dengan terus-menerus untuk mengurangi resiko terhadap pasien maupun staf baik dalam proses klinis maupun lingkungan fisik.

Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien tersebut harus dapat diukur melalui pencapaian indikator - indikator yang ditetapkan mulai tingkat rumah sakit, nasional, maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan mutu pelayanan yang baik dan tercapainya keselamatan pasien maka perlu dibuat program peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berisi tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan disusun secara rinci.

1.2 Dasar Hukum

- 1.2.1.** Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.2.** Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 1.2.3.** Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 1.2.4.** Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.5.** Instrumen Survei Akreditasi RS 2024
- 1.2.6.** Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.7.** Buku Standar Akreditasi RS Kemenkes RI 2022
- 1.2.8.** Peraturan Menteri Kesehatan No 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
- 1.2.9.** Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- 1.2.10.** Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 200.50/DPM/I-KEP/DIR/II/2022 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
- 1.2.11.** Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 773.145/I-KEP/DIR/VI/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada
- 1.2.12.** Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 2254.5/RSPHS/I-PER/DIR/X/2022 tentang Pedoman Kerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

1.3.2 Tujuan

- 1. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sesuai dengan standar indikator yang ada.
- 2. Meningkatkan keselamatan pasien melalui pelaporan insiden dan penerapan sasaran keselamatan pasien
- 3. Tersedianya SDM yang profesional dan berkualitas
- 4. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan medis yang memadai

-
5. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk karyawan, pasien dan pengunjung rumah sakit.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Visi Unit

Menjadikan keselamatan pasien dan Keselamatan pasien sebagai budaya organisasi dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas serta aman, terstandar, manusiawi serta memenuhi harapan seluruh pelanggan

2.2. Misi Unit

1. Menyelenggarakan pelayanan rumah sakit sesuai standar mutu pelayanan rumah sakit.
2. Membudayakan mutu dan keselamatan melalui upaya-upaya pendidikan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada seluruh staf pelayanan.
3. Mengintegrasikan kegiatan pendidikan dan penelitian kedalam kegiatan keselamatan pasien dan Keselamatan pasien.
4. Merancang dan melaksanakan sistem pemantauan indikator, menganalisa serta merancang ulang proses pelayanan secara berkelanjutan.
5. Menjadikan pasien sebagai fokus utama seluruh upaya keselamatan pasien dan keselamatan dengan tidak mengabaikan regulasi serta kepentingan institusi

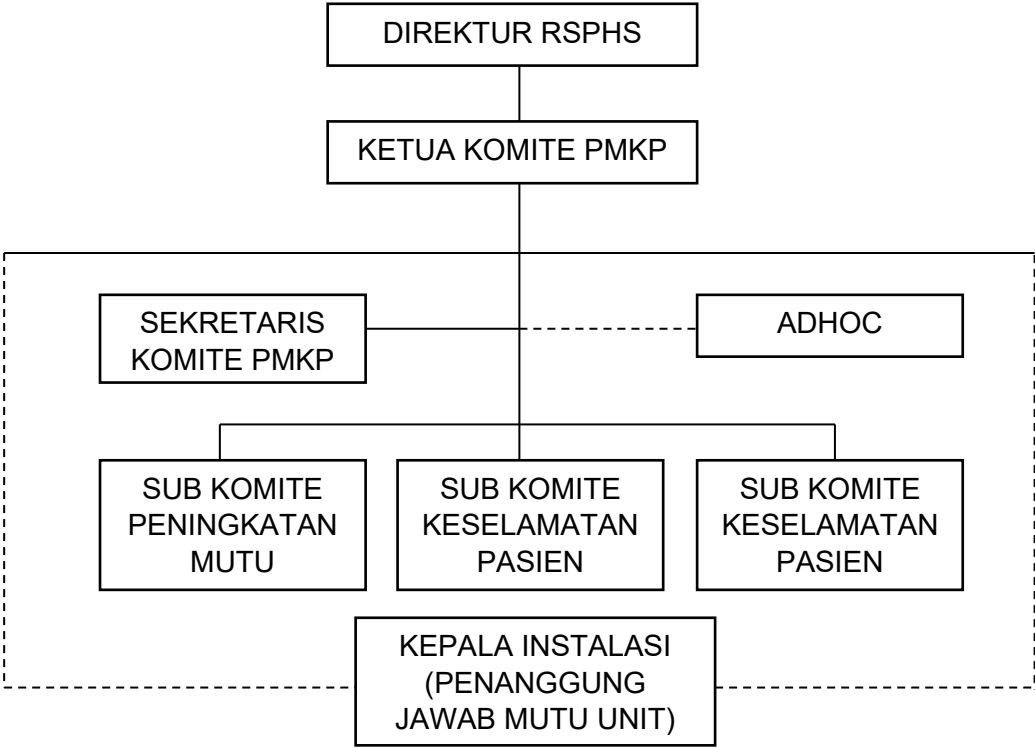
2.3. Motto

Kepuasan anda adalah kebahagiaan kami

2.4. 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur + Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerja sama
6. Adil
7. Peduli

2.5. SOTK Komite PMKP



BAB III
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Pemenuhan Kebutuhan SDM	Berdasarkan PMK No 80 Tahun 2020 Susunan Organisasi Komite Mutu paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, tetapi di RS Prima Husada Sukorejo belum terpenuhi adapun perinciannya sebagai berikut: 1. Hanya terdapat penanggung jawab program Mutu RS perlunya Penambahan Dokter Umum sebagai Ketua Komite PMKP di RS Prima Husada Sukorejo 2. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu belum ada 3. Ketua Sub Keselamatan Pasien belum ada 4. Ketua Komite Manajemen Resiko belum ada 5. Kepala Instalasi (Penanggung jawab) unit 39 orang sudah terpenuhi 6. PIC Data Mutu Unit 39 orang sudah terpenuhi
2.	Pendidikan dan Pelatihan (Seminar dan Workshop) terkait Mutu	1. Pelatihan Eksternal: • Sasaran: Ketua Komite PMKP, Sekretaris Komite PMKP, Sub Komite Peningkatan Mutu, Sub Komite Keselamatan Pasien, Sub Komite Manajemen Resiko • Materi: a. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko b. Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA) c. Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP • Seminar dan Workshop harus dari KARS sebagai Standar Akreditasi Rumah Sakit 2. Pelatihan Internal: a. Orientasi Umum: • Sasaran: Pegawai baru di RS Prima Husada Sukorejo • Materi: Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo

		b. <i>Refreshment & Training</i> PMKP untuk keseluruhan staf di RS Prima Husada Sukorejo: • Sasaran: Keseluruhan staff di RS Prima Husada Sukorejo (Dokter, Perawat, Bidan, Gizi, Farmasi, dsb) • Materi: 1) Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit 2) Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 3) Budaya Keselamatan Pasien 4) Manajemen Resiko c. Pelatihan Pengambilan Data Mutu: • Sasaran: PIC Data Mutu di setiap Unit • Materi: 1) Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2) Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> 3) Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4) Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name</i> 5) Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS d. Pelatihan terkait pengisian CP di Unit: (Kolaborasi dengan Komite Medik) • Sasaran: PPA (Program Pemberi Asuhan) yakni DPJP, Perawat, Bidan, Gizi dan Farmasi • Materi: 1) Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2) Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>
3.	Regulasi terkait Komite Mutu	• RS Prima Husada Sukorejo menetapkan kebijakan dan langkah-langkah upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta manajemen resiko di rumah sakit. untuk dapat melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit, maka langkah awal yang

		perlu dilakukan adalah kebijaksanaan dan langkah-langkah upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dari Direktur. - Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i>. Regulasi yang perlu di review yakni: 1. Penetapan SK Komite Mutu 2. Penetapan SK PJ Mutu 3. Penetapan SK PIC Mutu 4. Penetapan SK Validator Mutu 5. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS 6. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS 7. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) 8. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit 9. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit
4.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%) 3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ($>80\%$) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif ($<5\%$) 7. Kepatuhan waktu visite dokter ($\geq 80\%$) 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$) 10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$) 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq 80\%$) 13. Kepuasan pasien (76.61%)

		Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: - Terlaksananya pengumpulan dan analisa data - Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR - Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan - Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu
5.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS)	- Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. - Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: - Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) - Indikator Pelayanan Klinis Prioritas - Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) - Indikator terkait Perbaikan Sistem - Indikator terkait Manajemen Risiko - Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur - Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data - Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS
6.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit	Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut: - Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit - Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit - IGD - Instalasi Rawat Jalan - Instalasi Rawat Inap 2A - Instalasi Rawat Inap 2B - Instalasi Rawat Inap 3A - Instalasi Rawat Inap 3B - Instalasi Kamar Operasi - Maternitas

		i. Ponak j. Neonatologi k. ICU l. Radiologi m. Laboratorium n. Rehab Medis o. Farmasi p. Gizi q. Rekam Medis r. Limbah-K3RS s. SDM t. Kesekretariatan u. Driver v. Pemulasaran Jenazah w. ATEM-IPSRS x. Laundry y. CSSD z. Cleaning Service - aa. Keamanan - bb. Gudang Umum - cc. PPI - dd. PKRS - ee. Verifikator - ff. Humas & Marketing - gg. MOD-MPP-PIPP - hh. TB di IRJA ii. Keuangan - jj. HIV - kk. KB - ll. Stunting - mm. IT-SIMRS 3. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data
--	--	--

		4. Terlaksananya pelaporan indikator mutu unit 5. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan 6. Terlaksananya monitoring mutu unit kerja
7.	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintergrasi	1. Terlaksananya pengumpulan data indikatotor mutu oleh PIC disetiap unit kerja sesuai dengan profil indikator 2. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data 3. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan validasi data 4. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik 5. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja 6. Terlaksananya publikasi data indikator mutu 7. Terlaksananya <i>benchmark</i> data
8.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit	Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan oleh Direktur, maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua komite medik menetapkan paling sedikit 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran. 1. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik
9.	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS 2. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading 3. Terlaksana pelaporan IKP ke representative pemilik 4. Terlaksananya pelaporan IKP secara eksternal ke KNKP
10.	Pengukuran Budaya Keselamatan	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

		1. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan 2. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan
11.	Penerapan Manajemen Risiko	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Menyusun Risk register 3. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit 5. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik 6. Menyusun FMEA 7. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA

3.2. Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	Penambahan Ketua Komite PMKP full time (diutamakan dengan latar pendidikan Dokter Umum)	Optimalisasi program & strategi pelaksanaan PMKP	Dokter Umum	Rekrutmen	Terpenuhi	Penambahan 1 staff untuk Ketua Komite PMKP	-
2.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Risiko	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu 4. Ketua Sub Keselamatan Pasien 5. Ketua Sub Manajemen Risiko	Diklat	1 kali dalam setahun	Adanya : 1. Sertifikat 2. Materi 3. Laporan 4. Surat Tugas	Diklat diselenggarakan oleh KARS

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
3.	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Keselamatan Pasien	Diklat	1 kali dalam setahun	Adanya : 1. Sertifikat 2. Materi 3. Laporan 4. Surat Tugas	Diklat diselenggarakan oleh KARS
4.	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua Komite PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu	Diklat	1 kali dalam setahun	Adanya : 1. Sertifikat 2. Materi 3. Laporan 4. Surat Tugas	Diklat diselenggarakan oleh KARS
5.	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Meningkatkan pengetahuan karyawan baru terkait program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Karyawan Baru	Pembelajaran Kontekstual	Terpenuhi	1. 100% karyawan baru mengikuti pelatihan 2. 100% karyawan baru yang mengikuti pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan	-
6.	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: 1. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit	Memperkuat dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan terkait program Peningkatan Mutu	All Staff	Sosialisasi & Pelatihan	100% karyawan	1. 100% karyawan mengikuti pelatihan 2. 100% karyawan yang mengikuti pelatihan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	2. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 3. Budaya Keselamatan Pasien 4. Manajemen Resiko	dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo				mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan	
7	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: 1. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> 3. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name</i> .	Meningkatnya kemampuan PIC Mutu Unit dalam pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data	PIC Mutu Unit	Pelatihan Internal	1 kali dalam setahun	1. Semua PIC dapat mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasi indikator mutu unit nya 2. Semua PIC mutu mendapatkan sertifikat pelatihan pengambilan data mutu	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	5. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS						
8.	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: 1. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Meningkatnya kemampuan PPA (Profesional Pemberi Asuhan) pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data	Karu Rawat Inap, Dokter, Gizi, Farmasi	Pelatihan Internal	1 kali dalam setahun	1. Semua PPA dapat mengisi Form CP 2. Semua PPA mendapatkan sertifikat pelatihan pengisian CP	
9.	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i> . Regulasi yang perlu di review yakni: 1. Penetapan SK Komite Mutu 2. Penetapan SK PJ Mutu 3. Penetapan SK PIC Mutu 4. Penetapan SK Validator Mutu 5. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS	Memperbarui regulasi mutu sesuai dengan undang-undang / PMK yang berlaku	Komite PMKP	Review Dokumen Regulasi	1 kali dalam setahun	Regulasi dapat terbaru sesuai UU/PMK/Pedoman Terbaru	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	6. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS 7. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) 8. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit 9. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit						
10.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut:	Sebagai tolak ukur kepatuhan dan bahan analisa capaian RS dalam menjalankan INM	Setiap Unit di RS	Observasi lapangan	Setiap bulan	Indikator Nasional Mutu terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%) 3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ($>80\%$) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif ($<5\%$) 7. Kepatuhan waktu visite dokter ($\geq 80\%$) 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$) 10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$)						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq$ 80%) 13. Kepuasan pasien (76.61%) Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: a. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data b. Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR c. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan d. Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu						
11.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS) 1. Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada	Memilih Indikator Mutu Prioritas RS 2025 pada tahun 2024, untuk dilakukan target	Pelayanan Bedah	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)	1. Penentuan IMP RS dilakukan 1 kali dalam setahun	1. Indikator Mutu Prioritas RS terlaksana dengan data real dan sesuai	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: - Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) - Indikator Pelayanan Klinis Prioritas - Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) - Indikator terkait Perbaikan Sistem - Indikator terkait Manajemen Risiko	perbaikan pada tahun 2025			- Pengambilan data IMP RS dilakukan setiap hari - Pelaporan Capaian Indikator Mutu dilakukan setiap bulan	dengan kondisi lapangan 2. Adanya SK penetapan Indikator Mutu Prioritas RS	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	3. Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur. 4. Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data 5. Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS						
12.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut: 1. Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit 2. Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD	Memilih Indikator Mutu Prioritas Unit 2025 pada tahun 2024, untuk dilakukan target perbaikan pada tahun 2025	Setiap unit di RS	FGD	1. Penentuan IMP Unit dilakukan 1 kali dalam setahun 2. Pengambilan data IMP Unit dilakukan setiap hari 3. Pelaporan Capaian Indikator Mutu dilakukan setiap bulan	1. Indikator Mutu Prioritas Unit terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan 2. Adanya SK penetapan Indikator Mutu Prioritas Unit	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2B e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 3B g. Instalasi Kamar Operasi h. Maternitas i. Ponak j. Neonatologi k. ICU l. Radiologi m. Laboratorium n. Rehab Medis o. Farmasi p. Gizi q. Rekam Medis r. Limbah-K3RS s. SDM t. Kesekretariatan u. Driver v. Pemulasaran Jenazah w. ATEM-IPSRs x. Laundry						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	y. CSSD z. Cleaning Service aa. Keamanan bb. Gudang Umum cc. PPI dd. PKRS ee. Verifikator ff. Humas & Marketing gg. MOD-MPP-PIPP hh. TB di IRJA ii. Keuangan jj. HIV kk. KB ll. Stunting mm. IT-SIMRS 3. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data 4. Terlaksananya pelaporan indikator mutu unit 5. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan 6. Terlaksananya monitoring mutu unit kerja						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
13.	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintegrasi 1. Terlaksananya pengumpulan data indikatotor mutu oleh PIC disetiap unit kerja sesuai dengan profil indikator 2. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data 3. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan validasi data 4. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik 5. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja 6. Terlaksananya publikasi data indikator mutu. 7. Terlaksananya <i>benchmark</i> data	Untuk mendata setiap indikator yang berlaku di setiap unit sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisis berbaikan / berburukan dan dilakukan tindaklanjut dan <i>feedback</i> perbaiki kepada setiap unit	Setiap unit di RS	Observasi lapangan & Analisa data	1. Terlaksana 100% 2. Terlaksana 100% 3. Terlaksana 100% 4. Terlaksana 100% 5. Terlaksana 100% 6. Terlaksana 100% 7. Terlaksana 100%	Terlaksananya tindak lanjut untuk setiap unit yang melaporkan capaiannya	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
14.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit. Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan oleh Direktur, maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua komite medik menetapkan paling sedikit 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran. 1. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik	1. Untuk menilai efektivitas penerapan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit 2. Untuk mengurangi variasi dari proses, hasil dan efisiensi biaya	1. PPA (Profesional Pemberi Asuhan) yakni: a. DPJP b. Perawat/Bidan c. Gizi d. Farmasi 2. Komite PMKP 3. Komite Medik	Observasi lapangan & Analisa data	1 bulan sekali	Terlaksananya audit medis di setiap pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran	
15.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak	Sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian petugas dalam meningkatkan budaya lapor IKP yang terjadi di unitnya dan	Setiap unit di RS	Laporan IKP	1. Terlaksana setiap kali terjadi insiden 2. Terlaksana setiap kali terjadi insiden	setiap IKP dilaporkan < 2 x 24 jam terutama KPC yang terjadi di unit	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS 2. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading 3. Terlaksana pelaporan IKP ke representative pemilik 4. Terlaksananya pelaporan IKP	sebagai bukti bahwa RS telah memprioritaskan keselamatan pasien			3. Terlaksana setiap 3 bulan sekali 4. Terlaksana setiap bulan sekali		

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	secara eksternal ke KNKP						
16.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan 2. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	untuk mengukur tingkat budaya keselamatan pasien dan Menyusun program kerja keselamatan pasien pada tahun berikutnya	All Staf di RS Prima Husada Sukorejo	Survey	1 kali dalam setahun	Pengukuran dapat terlaksana dan dilaporkan kepada direktur & PT 1 kali dalam setahun	
17.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Menyusun Risk register	untuk menghindari risiko yang dimiliki di unit agar dapat terminimalisis kejadiannya dan menganalisis alur sebelum insidennya terjadi	Setiap unit di RS	Observasi dan analisa	1 kali dalam setahun	Tercatatatnya risiko yang terjadi di setiap unit dan pengendalian risiko di unit dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil pada risk register	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	3. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit 5. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik 6. Menyusun FMEA 7. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA						

3.3. Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1.	Penambahan Ketua Komite PMKP full time (diutamakan dengan latar pendidikan Dokter Umum)	1. Pengajuan SDM 2. Rekrutmen Staff	Seleksi Kompetensi	Media Poster	Januari 2025	1. Poster Rekrutmen 2. Kontrak Kerja 3. SK Pegawai	
2.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	1. Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom - Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
3.	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	
4.	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	
5.	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	1. Undangan 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT - Google Classroom	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari Perekrutan SDM)	1. UMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. LPJ	
6.	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: 1. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit 2. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	1. Pengajuan TOR 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT Google Classroom	Bulan Maret 2025 Bulan Juni 2025 Bulan Desember 2025	1. TUMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. Sertifikat 4. LPJ	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	3. Budaya Keselamatan 4. Manajemen Resiko						
7.	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: 1. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> 3. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name</i> . 5. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS	1. Undangan 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT - SIMRS - Google Classroom - Google Spreadsheet	Bulan Januari 2025	1. UMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. LPJ	
8.	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi:	1. Pengajuan TOR 2. Pelaksanaan	Diklat Internal	- PPT - Google Spreadsheet	Bulan Januari 2025	1. TUMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. Sertifikat	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	1. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	3. LPJ				4. LPJ	
9.	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i> . Regulasi yang perlu di review yakni: 1. Penetapan SK Komite Mutu 2. Penetapan SK PJ Mutu 3. Penetapan SK PIC Mutu 4. Penetapan SK Validator Mutu 5. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS 6. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS 7. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien	Membandingkan peraturan baru dan pedoman / SPO / Alur yang dimiliki oleh komite mutu	Review dokumen	Pedoman	Bulan Januari 2025	Perbaikan regulasi	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	Rumah Sakit (SP2KP RS) 8. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit 9. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit						
10.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%)	Melakukan pemantauan secara berkesinambungan melalui pengecekan pengambilan data, kevalidan dari lembar laporan harian kepada setiap kepala ruangan	Observasi lapangan	Instrumen pengambilan data	Januari – Desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi (>80%) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif (<5%) 7. Kepatuhan waktu visite dokter ($\geq 80\%$) 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$) 10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$) 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq 80\%$)						

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	13. Kepuasan pasien (76.61%) Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: - Terlaksananya pengumpulan dan analisa data - Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR - Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan - Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu						
11.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS): Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada	Diskusi Bersama dengan kepala ruang, PIC, komite dan direksi untuk dilakukan grading dalam menentukan layanan prioritas yang akan di	FGD	Diskusi & tanya jawab	Oktober – Desember 2024	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko 3. Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan	selesaikan pada tahun mendatang					

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	melalui SK penetapan direktur. 4. Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data 5. Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS						
12.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut: 1. Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit 2. Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan	Diskusi Bersama dengan kepala ruang, PIC, komite dan direksi untuk menjelaskan maslaah yang terjadi di setiap unit, SPM dan memilih masalah yang akan di gunakan sebagai indikator mutu unit pada tahun mendatang	FGD	Instrumen pangambilan data	Oktober – Desember 2024	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2B e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 3B g. Instalasi Kamar Operasi h. Maternitas i. Ponsek j. Neonatologi k. ICU l. Radiologi m. Laboratorium n. Rehab Medis o. Farmasi p. Gizi q. Rekam Medis r. Limbah-K3RS s. SDM t. Kesekretariatan u. Driver v. Pemulasaran Jenazah w. ATEM-IPSRS x. Laundry						

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	y. CSSD z. Cleaning Service aa. Keamanan bb. Gudang Umum cc. PPI dd. PKRS ee. Verifikator ff. Humas & Marketing gg. MOD-MPP-PIPP hh. TB di IRJA ii. Keuangan jj. HIV kk. KB ll. Stunting mm. IT-SIMRS 3. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data						
13.	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintegrasi 1. Terlaksananya pengumpulan data indikator mutu oleh PIC disetiap unit kerja sesuai dengan profil indikator 2. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator	Melakukan pemantauan secara berkesinambungan melalui pengecekan pengambilan data, kevalidan dari lembar laporan	Observasi lapangan & Analisa data	Instrumen pengambilan data	Januari – desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	sesuai dengan ketentuan analisa data 3. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan validasi data 4. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik 5. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja 6. Terlaksananya publikasi data indikator mutu 7. Terlaksananya <i>benchmark</i> data	harian kepada setiap kepala ruangan					
14.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit. Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan oleh Direktur, maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua	Melakukan pemantauan CP Pasien dengan membandingkan observasi lapangan	Observasi lapangan & Analisa data	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	komite medik menetapkan paling sedikit 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran. 1. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik						
15.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading.	Melaporkan insiden yang terjadi di unit menggunakan form laporan dan billing RS	Laporan langsung / tidak langsung	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS 2. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading 3. Terlaksana pelaporan IKP ke representative pemilik 4. Terlaksananya pelaporan IKP secara eksternal ke KNKP						
16.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan	Melakukan survei secara online menggunakan google form dengan sasaran seluruh petugas	Survey	Instrumen pangambilan data	Juni 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	2. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan						
17.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Menyusun Risk register 3. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit 5. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik 6. Menyusun FMEA 7. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA	Melakukan Analisa resiko yang mungkin terjadi di unitnya Bersama dengan kepala ruang dan tim manajemen risiko dan membuat risk register	Observasi dan analisa	Instrumen pangambilan data	Desember 2024	UMANDOK	

3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Penambahan Ketua Komite PMKP full time (diutamakan dengan latar pendidikan Dokter Umum)	Dokter Umum		√												RSPHS	SDM RS	PT Disa Prima Medika
2.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu 4. Ketua Sub Keselamatan Pasien 5. Ketua Sub Manajemen Risiko	Tentatif menyesuaikan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS												Tergantung Penyelenggaraan	SDM RS	PT Disa Prima Medika	
3.	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP	Tentatif menyesuaikan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS												Tergantung Penyelenggaraan	SDM RS	PT Disa Prima Medika	

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	(FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	3. Ketua Sub Keselamatan Pasien																
4.	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu	9&10 Desember 2024													Zoom	SDM RS	PT Disa Prima Medika
5.	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Karyawan Baru	Tentatif menyesuaikan Jadwal Orientasi dari SDM RS Prima Husada Sukorejo												Hall Sakura RSPH Sukorejo	Komite PMKP	-	
6.	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: 1. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit 2. Macam-macam Insiden Keselamatan	Seluruh Staff di RS Prima Husada Sukorejo				√			√						√	Hall Sakura RSPH Sukorejo	Komite PMKP	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 3. Budaya Keselamatan 4. Manajemen Resiko																	
7.	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: 1. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> 3. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan	PIC Data Mutu Unit		√												Hall Andalusia Lantai 3 RSPH Sukorejo	Komite PMKP	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	4. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name.</i> 5. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS																	
8.	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: 1. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Karu Rawat Inap, Dokter, Gizi, Farmasi		√												Hall Andalusia Lantai 3 RSPH Sukorejo	Komite PMKP Komite Medik	-
9.	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi yang perlu di review yakni:			√														
	a. Penetapan SK Komite Mutu	Direktur RS		√												Sekretariat	Komite PMKP	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	b. Penetapan SK PJ Mutu	Komite PMKP		√														
	c. Penetapan SK PIC Mutu	Komite PMKP		√														
	d. Penetapan SK Validator Mutu	Direktur RS		√														
	e. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS	Direktur RS		√														
	f. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS	Direktur RS		√														
	g. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS)	Direktur RS		√														
	h. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit	Direktur RS		√														
	i. Penetapan tentang Program	Direktur RS		√														

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit																		
10.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	a. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data	All Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	d. Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
11.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS):			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan.	Direktur RS & Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup:	Direktur RS & Komite PMKP	√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko																		
	Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur	Direktur RS	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data	Komite PMKP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS	Komite PMKP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
12.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator.																		
	Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit	Komite PMKP Kepala Unit	√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2B e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 3B g. Instalasi Kamar Operasi h. Maternitas i. Ponsek		√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	j. Neonatologi																	
	k. ICU																	
	l. Radiologi																	
	m. Laboratorium																	
	n. Rehab Medis																	
	o. Farmasi																	
	p. Gizi																	
	q. Rekam Medis																	
	r. Limbah-K3RS																	
	s. SDM																	
	t. Kesekretariatan																	
	u. Driver																	
	v. Pemulasaran Jenazah																	
	w. ATEM-IPSRs																	
	x. Laundry																	
	y. CSSD																	
	z. Cleaning Service																	
	aa. Keamanan																	
	bb. Gudang Umum																	
	cc. PPI																	
	dd. PKRS																	
	ee. Verifikator																	
	ff. Humas & Marketing																	
	gg. MOD-MPP-PIPP																	
	hh. TB di IRJA																	
	ii. Keuangan																	

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	jj. HIV kk. KB ll. Stunting mm. IT-SIMRS																		
	Terlaksananya pengumpulan dan analisa data	Komite PMKP Kepala Unit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	13	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintergrasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	a. Terlaksananya pengumpulan data indikatotor mutu oleh PIC disetiap unit kerja sesuai dengan profil indikator	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Terlaksananya validasi data	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	sesuai dengan ketentuan																		
	d. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik	PIC Data Mutu Kepala Unit Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	e. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	f. Terlaksananya publikasi data indikator mutu	Komite PMKP		√			√			√			√			Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	g. Terlaksananya <i>benchmark</i> data	Komite PMKP		√			√			√			√			Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	14.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	a. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik	Komite Medik Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	b. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik	Komite Medik Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
15.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	berdasarkan hasil grading.																		
	a. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Terlaksananya pelaporan IKP ke representative pemilik	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya pelaporan IKP secara eksternal ke KNKP	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
16.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya								√										

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	keselamatan pasien setiap tahun.																		
	a. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan	All Karyawan RSPH Sukorejo							√							Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	Komite PMKP							√	√						Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
17.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun.		√																
	a. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS	All Unit	√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP Komite PPI Komite K3RS	-	-
	b. Menyusun Risk register	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	c. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	e. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	f. Menyusun FMEA	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	g. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

3.5. Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RS Prima Husada Sukorejo yang telah disetujui oleh PT. Disa Prima Medika dengan rincian sebagaimana terlampir:

Tabel 3.5. Kebutuhan biaya pengembangan SDM Komite PMKP tahun 2025

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Penambahan Ketua Komite PMKP full time (diutamakan dengan latar pendidikan Dokter Umum)	Eksternal	1	Rp 20.000	Rp 20.000
2	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	Eksternal	5	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000
3	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Eksternal	3	Rp 3.500.000	Rp 10.500.000
4	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Eksternal	3	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
5	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000
6	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: a. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien c. Budaya Keselamatan	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
	d. Manajemen Resiko				
7	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: a. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit b. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> c. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name</i> . e. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000
8	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: a. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit b. Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000
9	Honorarium narasumber pelatihan insidentil (DPJP) 4 kali pelatihan x 4 org DPJP	Eksternal	20	Rp 250.000	Rp 5.000.000
TOTAL					Rp 46.720.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring

Sesuai dengan Permenkes No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, kegiatan monitoring Komite PMKP dilakukan dalam bentuk:

1. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan program mutu di unit kerja
2. Monitoring, supervisi dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu
3. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja
4. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja

4.2. Evaluasi

Sesuai dengan Permenkes No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, kegiatan evaluasi Komite PMKP dilakukan dalam bentuk:

1. Rapat rutin dengan PIC Data Unit terkait capaian indikator mutu unit setiap bulan
2. Rapat Triwulanan dengan Kepala Ruang dan Jajaran Manajemen terkait capaian indikator mutu, insiden keselamatan pasien yang ada di unit
3. Pemberian masukan dan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit terkait perbaikan mutu tingkat Rumah Sakit
4. Rapat pemilihan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit dan pengukuran indikator tingkat Rumah Sakit serta menindaklanjuti hasil capaian indikator
5. Rapat pemilihan risk register unit dengan Kepala Ruang, Seluruh Komite dan jajaran Manajemen untuk dilakukan profil register.
6. Motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien
7. Melakukan Root Cause Analysis (RCA) dan pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien
8. Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali oleh bidang bagian dan dianalisa setiap triwulan, untuk di berikan rekomendasi dan di sampaikan kepada Pemilik (Direktur PT)
9. Setelah ada feedback maka disampaikan melalui direktur ke Komite Mutu, Komite Mutu menyampaikan feedback kepada manajer untuk ditindak lanjuti

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Kegiatan pengumpulan data indikator mutu dilakukan oleh PIC data unit dengan menggunakan worksheet yang ada di google yang ada di google drive
2. Data yang dikumpulkan diverifikasi oleh kepala instalasi dan dilihat apakah sudah sesuai dengan profil indikator atau belum.
3. Setiap capaian indikator di rekapitulasi setiap bulan, dilengkapi dengan analisa dan tindak lanjut.
4. Setiap tiga bulan, data tersebut direkap dan dianalisis oleh manajer menjadi laporan triwulan sebagai bentuk evaluasi unit.
5. Komite Mutu bertugas melakukan validasi data hasil kegiatan jika hasil kegiatan jika ada data yang harus dievaluasi sesuai kebutuhan dalam prosedur validasi.
6. Setelah data valid maka laporan dari hasil analisa analisa setiap unit direkap menjadi laporan hasil kegiatan rumah sakit, Direktur RS melaporkan kepada Direktur PT Pemilik RS
7. Setelah ada Feedback dari Direktur PT Pemilik RS kepada Direktur RS maka disosialisasikan kepada semua manajer untuk penyusunan tindak lanjut dan diinformasikan kepada semua staf diunit kerja.
8. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dari setiap kegiatan setiap kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan, hasil evaluasi disampaikan oleh Komite Mutu dan diserahkan ke Direktur PT Pemilik RS untuk ditindaklanjuti.

BAB VI
PENUTUP

Demikian program kerja Komite Mutu disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2025. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program kerja yang sudah disusun.

Mengetahui
Komite Mutu



Lidia Puspita Kencana, S.K.M.

Pasuruan, 16 November 2024
Menyetujui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS